

HANTAVIRUS

ENTRE EL MIEDO, LA VERDAD Y LA MANIPULACIÓN SOCIAL

Por: Manolo Fernández D.

MV, MSC, PhD h.c.

08 de mayo de 2026

En una época donde las noticias viajan más rápido que el pensamiento crítico, el miedo se ha convertido en una poderosa herramienta de control colectivo. Cada cierto tiempo aparece una amenaza sanitaria presentada como el inicio de una catástrofe global. Los medios multiplican titulares alarmantes, las redes sociales expanden rumores de manera viral y la población comienza a vivir bajo una ansiedad permanente que condiciona comportamientos, decisiones y percepciones sobre la realidad. En medio de ese escenario de pánico orquestado, muchas veces se dejan de discutir problemas más profundos y estructurales: la pobreza que impide acceso a servicios básicos, la corrupción que debilita las instituciones sanitarias, la inseguridad que golpea las comunidades, la crisis económica que empobrece familias, el abandono sanitario en zonas rurales y la desigualdad social que perpetúa vulnerabilidades. Mientras la atención colectiva está fijada en la amenaza de turno, los verdaderos problemas sistémicos permanecen invisibilizados y sin resolución.

Hoy uno de esos nombres vuelve a ocupar espacios de alarma mediática: el Hantavirus.

El hantavirus existe y puede ser grave. Sería fundamentalmente irresponsable, desde el punto de vista científico y ético, negarlo o minimizarlo de manera absoluta. Este es un patógeno real que ha causado brotes documentados, enfermedades confirmadas y muertes registradas en diversas regiones del mundo, particularmente en Sudamérica, Asia y América del Norte. Sin embargo, también es igualmente irresponsable exagerar su capacidad de contagio de manera sensacionalista, presentarlo como una amenaza apocalíptica fuera de contexto epidemiológico o permitir que el fenómeno mediático supere sustancialmente a la realidad clínica y epidemiológica del virus.

La ciencia y la virología han demostrado consistentemente que esta enfermedad, formalmente conocida como el Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH) o Fiebre Hemorrágica Renal (FHR) según la variante viral, se transmite principalmente a través del contacto directo con roedores infectados o de manera más significativa, mediante la inhalación de partículas aerosolizadas provenientes de la orina, heces y saliva secas de estos animales contaminados. El virus permanece viable en el ambiente durante períodos limitados, y la transmisión requiere generalmente de condiciones específicas: espacios cerrados mal ventilados, acumulación de excrementos de roedores, polvo contaminado resuspendido en el aire y ausencia de medidas básicas de higiene ambiental. Esto vincula directamente el riesgo epidemiológico con las condiciones de vida precaria, la carencia de infraestructura sanitaria, la desnutrición que compromete inmunidad y, fundamentalmente, con la pobreza estructural.

El hantavirus pertenece a la familia Bunyaviridae y se caracteriza por ser un virus de ARN de polaridad negativa segmentado en tres segmentos genómicos. Existen múltiples especies de hantavirus distribuidas geográficamente, cada una con características epidemiológicas y clínicas distintas. El virus Sin Nombre fue identificado en 1993 durante un brote en Estados Unidos. El virus Andes, identificado en Argentina en 1995, es de particular relevancia porque es la única especie documentada con capacidad confirmada de transmisión interpersonal, aunque esta transmisión es excepcionalmente rara y ocurre únicamente bajo condiciones muy específicas de contacto directo prolongado y cercano, frecuentemente entre contactos familiares de casos graves. El virus Puumala en Europa y Asia, el virus Seoul en regiones urbanas, y el virus Dobrava en los Balcanes representan otros brotes significativos documentados.

El período de incubación típico es de dos a cuatro semanas, aunque en casos excepcionales puede extenderse hasta dos meses. El virus se replica principalmente en células endoteliales de pequeños vasos sanguíneos, causando daño vascular, aumento de permeabilidad capilar y consecuentemente extravasación de fluidos. En la variante pulmonar, característica de Sudamérica, el virus induce un síndrome de dificultad respiratoria aguda particularmente agresivo que progresa rápidamente. En la variante hemorrágica renal, más frecuente en Eurasia, predomina la disfunción renal con manifestaciones hemorrágicas variables.

Este aspecto merece especial énfasis porque representa el punto de mayor distorsión en la narrativa mediática. La transmisión entre humanos es extraordinariamente baja, rara, y prácticamente inexistente fuera de muy pocas excepciones documentadas. Solo algunas variantes sudamericanas, específicamente el virus Andes, han mostrado un pequeño número de casos confirmados de contagio interpersonal, generalmente bajo contacto estrecho y prolongado, frecuentemente dentro de contextos familiares, ambientes hospitalarios sin protección adecuada o situaciones de cuidado directo de pacientes graves. Estos casos pueden contarse con los dedos de una mano en relación al millón de posibles transacciones virales que ocurren anualmente. **No estamos frente a un virus con comportamiento comparable al COVID-19 o a la influenza estacional, ambos caracterizados por transmisión aérea eficiente, períodos cortos de incubación y capacidad explosiva de propagación.** Presentar el hantavirus como una amenaza de transmisión masiva entre humanos es científicamente incorrecto y contribuye de manera directa y significativa a generar histeria colectiva injustificada.

La epidemiología real del hantavirus es fundamentalmente una enfermedad ocupacional o ambiental: afecta principalmente a trabajadores agrícolas, campesinos, mineros, constructores y personas en contacto frecuente con roedores o sus hábitats contaminados. En contextos urbanos bien estructurados con control de plagas y saneamiento adecuado, la incidencia es cercana a cero. El virus requiere condiciones muy específicas para transmitirse: espacios deficientemente ventilados, presencia masiva de roedores infectados, exposición repetida a partículas aerosolizadas y ausencia de medidas básicas de protección.

La mortalidad en casos confirmados puede ser elevada, particularmente cuando el cuadro pulmonar se complica severamente. Estudios epidemiológicos reportan tasas de mortalidad que oscilan entre el 25% y el 40% en formas graves respiratorias cuando el paciente llega al hospital ya en etapas avanzadas de la enfermedad. Esta cifra es significativa y justifica vigilancia epidemiológica seria, pero debe contextualizarse: la mayoría de exposiciones no resultan en infección, la mayoría de infecciones resultan en enfermedad leve, la mayoría de enfermedades leves resuelven espontáneamente, y el acceso temprano a cuidados intensivos mejora dramáticamente el pronóstico. En contextos con soporte médico de calidad, incluida oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) cuando es necesario, las tasas de supervivencia mejoran significativamente.

Se investigan activamente vacunas experimentales en múltiples laboratorios. Algunos países asiáticos, particularmente China y Corea del Sur, han desarrollado y aprobado formulaciones vacunales específicas contra ciertas cepas virales, principalmente el virus de Seúl, con datos limitados pero promisorios sobre eficacia. Sin embargo, estas vacunas no están disponibles globalmente, no cubren todas las variantes virales distribuidas geográficamente y siguen siendo objeto de investigación en cuanto a durabilidad y efectividad a largo plazo.

Tampoco existe un antiviral curativo específico ampliamente validado y aprobado contra el hantavirus. El arsenal terapéutico actual es fundamentalmente de apoyo: oxigenoterapia, hidratación intravenosa cuidadosa balanceada, monitoreo cardiovascular intensivo, soporte respiratorio mecánico cuando es necesario, manejo de coagulopatías, transfusiones de productos sanguíneos según requerimiento y soporte renal con diálisis cuando hay falla renal.

La prevención real del hantavirus no está en el pánico mediático inflamado ni en la espera de intervenciones farmacéuticas milagrosas. Está en acciones concretas, comprobadas y alcanzables dentro del sistema de salud pública actual.

Aquí surge la reflexión filosófica más importante y más incómoda para los que construyen narrativas de alarma: ¿por qué el miedo suele difundirse con una velocidad exponencialmente mayor que la verdad? ¿Por qué un titular que infunde pánico alcanza millones de personas en horas mientras un análisis científico riguroso permanece confinado a círculos especializados?

La historia humana demuestra de manera repetida y casi monótona que el temor colectivo ha sido utilizado consistentemente como instrumento de manipulación social, control político y concentración de poder. No necesariamente mediante mentiras absolutas y totales, sino amplificando riesgos reales hasta convertirlos en espectáculos emocionales capaces de dominar la atención pública. Un riesgo que es real pero estadísticamente menor puede ser presentado con tal intensidad mediática que la población lo percibe como amenaza apocalíptica. La brecha entre riesgo estadístico real y riesgo percibido es donde la manipulación ocurre.

El verdadero peligro no es un virus cuya transmisión entre humanos es extremadamente rara, sino una sociedad que ha permitido que el miedo gobierne la razón. No un patógeno cuya incidencia permanece baja cuando existen medidas preventivas de bajo costo, sino una población incapaz de resistencia cognitiva frente a narrativas construidas para servir agendas específicas.

Cuando el miedo gobierna, la libertad de pensar comienza a desaparecer silenciosamente. Y en el vacío dejado por la razón desaparecida, prospera la manipulación.

La verdadera salud pública requiere, más que vacunas sin disponibilidad o antivirales sin eficacia probada, una población que piense críticamente. Que pueda diferenciar. Que no tenga miedo a cuestionar. Que permanezca libre para razonar.

*Médico Veterinario especializado en Virología Aviar
FARVET - Farmacológicos Veterinarios S.A.C.*